



BỆNH VIỆN PHONG-DÀ LIỄU TW
QUY HÒA
KHOA VI SINH-MIỄN DỊCH

SỔ TAY CHẤT LƯỢNG

Mã số: XN-STCL

Lần ban hành: 2.0

Ngày ban hành:

...../01/2026

Số trang: 28

	Người biên soạn	Người kiểm tra	Người phê duyệt
Họ và tên	CKI.XN.Nguyễn Thái Hòa	Ths.Nguyễn Thị Bình	Ts.Vũ Tuấn Anh
Ký tên			
Chức vụ	KTV.Trưởng	Trưởng khoa	Giám đốc
Ngày	01/01/2026	05/01/2026	/01/2026

THEO DÕI SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

[illegible]

MỤC LỤC

1. Giới thiệu chung.....	1
1.1. Tóm tắt về Bệnh viện	1
1.2. Hoạt động Khoa Vi sinh-Miễn dịch	1
1.3. Tôn chỉ, tầm nhìn và giá trị cốt lõi của Khoa Vi sinh-Miễn dịch.....	2
1.3.1. Tôn chỉ.....	2
1.3.2. Tầm nhìn	2
1.3.3. Giá trị cốt lõi	2
2. Chính sách, mục tiêu và cam kết chất lượng.....	2
2.1. Chính sách chất lượng	2
2.2. Mục tiêu chất lượng.....	3
2.3. Cam kết của lãnh đạo	4
3. Các chữ viết tắt và định nghĩa	5
3.1. Các chữ viết tắt.....	5
3.2. Định nghĩa	5
4. Sơ đồ tổ chức và trách nhiệm quản lý.....	10
4.1. Sơ đồ tổ chức.....	10
4.2. Trách nhiệm và quyền hạn của các cá nhân trong hệ thống quản lý chất lượng.11	
4.2.1. Lãnh đạo Bệnh viện.....	11
4.2.2. Lãnh đạo Khoa	11
4.2.3. Quản lý chất lượng	12
4.2.4. Quản lý kỹ thuật	12
4.2.5. Nhân viên PXN	12
5. Các yêu cầu cụ thể	13
5.1. Tổ chức quản lý.....	13
5.1.1. Tổ chức và trách nhiệm quản lý.....	13
5.1.2. Xem xét của lãnh đạo.....	13
5.2. Tài liệu và hồ sơ.....	14
5.2.1 Tài liệu hệ thống quản lý	14
5.2.2. Kiểm soát tài liệu	15
5.2.3. Quản lý hồ sơ	16
5.3. Quản lý nhân sự.....	166
5.4. Dịch vụ và quản lý khách hàng	17
5.4.1. Dịch vụ tư vấn.....	17
5.4.2. Giải quyết khiếu nại	17
5.5. Quản lý trang thiết bị:.....	17
5.6. Đánh giá nội bộ.....	18
5.7 Quản lý mua sắm hóa chất, vật tư, sinh phẩm	19
5.7.1. Mua sắm và dịch vụ bên ngoài	19
5.7.2. Hóa chất, vật tư, sinh phẩm	19

5.8. Quản lý quá trình xét nghiệm.....	20
5.8.1. Quá trình trước xét nghiệm.....	20
5.8.2. Quá trình xét nghiệm	20
5.8.3. Đảm bảo chất lượng kết quả xét nghiệm	211
5.8.4. Quá trình sau xét nghiệm	221
5.9. Quản lý thông tin.....	22
5.10. Xác định sự không phù hợp, hành động khắc phục và hành động phòng ngừa....	22
5.10.1. Xác định và kiểm soát sự không phù hợp	23
5.10.2. Hành động khắc phục.....	23
5.10.3. Hành động phòng ngừa.....	23
5.11. Cải tiến liên tục.....	23
5.12. Cơ sở vật chất và an toàn	244
6. Tài liệu tham khảo	258

1. Giới thiệu chung

1.1. Tóm tắt về Bệnh viện

Bệnh viện Phong-Da liễu TW Quy Hòa có 2 cơ sở: Cơ sở 1 đóng tại Quy Nhơn, cơ sở 2 đóng tại Quy Hòa. Hoạt động dưới sự chỉ đạo của Bộ Y tế. Được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 1929. Bệnh viện hằng năm với số lượng bệnh nhân đến khám ngày càng tăng mỗi năm hơn 100 nghìn lượt khám. Với hơn 600 giường nội trú đang cung cấp dịch vụ đặc biệt và chất lượng cao.

Bệnh viện Phong-Da liễu TW Quy Hòa bao gồm các Khoa, phòng sau: Phòng Tổ chức cán bộ, phòng Kế hoạch tổng hợp, Khoa khám bệnh, Khoa nội, Khoa nhi, Khoa da liễu, Khoa ngoại tổng hợp, Khoa ngoại Kỹ thuật cao, Khoa Giải phẫu bệnh, Khoa Sinh hóa-Huyết học-Truyền máu, Khoa Vi sinh-Miễn dịch, Khoa sinh học phân tử, khoa Chẩn đoán hình ảnh, v.v.

1.2. Hoạt động Khoa Vi sinh - Miễn dịch

- Khoa được thành lập vào năm 2015 cung cấp dịch vụ xét nghiệm cho bệnh viện và cho cả một số đơn vị khác thông qua dịch vụ xét nghiệm chẩn đoán, giám sát và công tác nghiên cứu. Vì vậy, Khoa Vi sinh – Miễn dịch Bệnh viện Phong – Da liễu Trung ương Quy Hòa phục vụ như là nơi hỗ trợ chuyên môn và đào tạo bao gồm các xét nghiệm tham chiếu từ các bệnh viện khác gửi đến.

- Khoa cung cấp dịch vụ những xét nghiệm chuyên biệt như sau: Vi sinh và Miễn dịch. Với đội ngũ cán bộ nhiều kinh nghiệm, khoa đã tham gia vào các chương trình nghiên cứu lâm sàng và dịch tễ học.

- Khoa đảm bảo rằng STCL được lập thành văn bản, được duy trì và được ứng dụng theo 12 thành tố tham gia quyết định chất lượng. Đây là một nỗ lực để bảo đảm với khách hàng hay người sử dụng dịch vụ về chất lượng cũng như hiệu quả xét nghiệm.

- Khoa đã phân công một nhân viên Quản lý Chất lượng và Quản lý Kỹ thuật có trách nhiệm cho việc bảo đảm chất lượng của toàn khoa. Nhân viên Quản lý Chất lượng của Khoa sẽ báo cáo cho lãnh đạo Khoa về mọi hoạt động của Khoa. Lãnh đạo Khoa báo cáo Giám đốc Bệnh viện các hoạt động của Khoa thông qua các cuộc họp định kỳ hàng tháng, 6 tháng hoặc 1 năm, hoặc bằng những văn bản hay trong các cuộc thảo luận.

- Khoa được trang bị nhiều máy móc hiện đại và cung cấp các dịch vụ xét nghiệm kỹ thuật cao theo nhu cầu của khách hàng gồm:

- + Máy miễn dịch tự động;
- + Máy xét nghiệm 108 dị nguyên tự động;
- + Máy định danh và kháng sinh đồ tự động;

.....

- Nhân lực của khoa hiện có 12 người, bao gồm:

- + 01 Thạc sĩ
- + 01 CKI.XN
- + 10 cử nhân đại học xét nghiệm

1.3. Tôn chỉ, tầm nhìn và giá trị cốt lõi của Khoa Vi sinh-Miễn dịch

1.3.1. Tôn chỉ

Khoa Vi sinh-Miễn dịch cung cấp các dịch vụ xét nghiệm Vi sinh và Miễn dịch “AN TOÀN, HIỆU QUẢ, HÀI LÒNG, CẢI TIẾN LIÊN TỤC” lấy sự hài lòng của khách hàng làm thước đo về chất lượng dịch vụ.

1.3.2. Tầm nhìn

Khoa Vi sinh – Miễn dịch nỗ lực phấn đấu để trở thành đơn vị xét nghiệm hàng đầu về cung cấp dịch vụ các xét nghiệm Vi sinh và Miễn dịch phục vụ tại bệnh viện và các tỉnh khu vực Nam trung bộ, Việt Nam.

1.3.3. Giá trị cốt lõi

Chất lượng cao;

Dịch vụ chuyên nghiệp;

Phục vụ tất cả vì khách hàng;

Hoạt động theo tinh thần tập thể.

2. Chính sách, mục tiêu và cam kết chất lượng

2.1. Chính sách chất lượng

Khoa Vi sinh-Miễn dịch cam kết:

- Cung cấp các dịch vụ chính xác, tin cậy và kịp thời nhằm đảm bảo chất lượng cho công tác chẩn đoán, giám sát, nghiên cứu và đào tạo.

- Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng phù hợp hướng tới tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế.
- Không ngừng cải tiến chất lượng nhằm đáp ứng các nhu cầu và yêu cầu chính đáng của khách hàng và nâng cao uy tín của Khoa với cơ quan quản lý và khách hàng.
- Định kỳ xem xét để đảm bảo sự phù hợp với định hướng phát triển của Khoa và Bệnh viện

2.2. Mục tiêu chất lượng

Dựa trên chính sách chất lượng Khoa xây dựng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng với các mục tiêu chung sau:

- Đảm bảo tính khách quan, trung thực, bảo mật trong công tác xét nghiệm
- Đảm bảo tính chính xác, tin cậy và kịp thời của kết quả xét nghiệm
- Xây dựng kế hoạch đào tạo/đào tạo liên tục hoặc tuyển dụng nhân lực đáp ứng yêu cầu thực tế
- Soát xét hệ thống tài liệu định kỳ theo kế hoạch
- Đảm bảo chất lượng của hóa chất, sinh phẩm sử dụng cho xét nghiệm
- Kiểm tra, hiệu chuẩn, bảo dưỡng thiết bị theo đúng kế hoạch và sửa chữa kịp thời khi cần thiết.
- Hạn chế tối đa sự không hài lòng của khách hàng với các dịch vụ cung cấp.
- Cải tiến liên tục hệ thống quản lý chất lượng.
- Hằng năm, Lãnh đạo Bệnh viện, Lãnh đạo Khoa và nhân viên Khoa sẽ xây dựng mục tiêu cụ thể cho từng năm trong cuộc họp xem xét của lãnh đạo.

2.3. Cam kết của lãnh đạo

Để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ và đáp ứng các yêu cầu của khách hàng, Lãnh đạo Bệnh viện Phong – Da liễu Trung ương Quy Hòa và Lãnh đạo Khoa Vi sinh-Miễn dịch cam kết:

- Trong phạm vi cho phép, tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ các nguồn lực cần thiết cho hoạt động của Khoa để đảm bảo độ tin cậy, tính chính xác và kịp thời của kết quả xét nghiệm;
- Thường xuyên bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ nghiên cứu viên, kỹ thuật viên để duy trì và nâng cao hiệu quả công việc;
- Thường xuyên cập nhật kỹ thuật, phương pháp tiên tiến để không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ;
- Xây dựng, duy trì và cải tiến liên tục hệ thống quản lý chất lượng phù hợp hướng tới đáp ứng các yêu cầu của quyết định 2429/QĐ-BYT;
- Phổ biến các chính sách, các quy định của Bệnh viện và của Khoa tới từng cán bộ, nhân viên;
- Lãnh đạo Bệnh viện và toàn thể cán bộ, nhân viên trong Khoa tuân thủ chính sách, quy định, quy trình và nỗ lực hoàn thành các mục tiêu của hệ thống quản lý chất lượng.
- Đảm bảo toàn bộ nhân viên và Lãnh đạo Khoa không chịu áp lực về thương mại, tài chính hoặc các áp lực khác làm ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ;
- Giữ mối quan hệ với các khoa/phòng trong bệnh viện, tăng cường hợp tác quốc tế với các tổ chức quốc tế trong cùng lĩnh vực hoạt động chuyên môn.

3. Các chữ viết tắt và định nghĩa

3.1. Các chữ viết tắt

ATSH	An toàn sinh học
BYT	Bộ Y tế
CDC	Trung tâm phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh
HDAT	Hướng dẫn an toàn
HDCV	Hướng dẫn công việc
HDTB	Hướng dẫn thiết bị
HTQLCL	Hệ thống quản lý chất lượng
ISO	Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế
PTN	Phòng thí nghiệm
QLCL	Quản lý chất lượng
QLKT	Quản lý kỹ thuật
QTKT	Quy trình kỹ thuật
QTQL	Quy trình quản lý
QTXN	Quy trình xét nghiệm
STCL	Sổ tay chất lượng
VSDT	Vệ sinh dịch tễ
CNTT	Công nghệ thông tin
WHO	Tổ chức Y tế Thế giới

3.2. Định nghĩa

- **Chất lượng** (Quality): Là mức độ tập hợp các đặc tính vốn có của một sản phẩm, dịch vụ hay phương pháp xét nghiệm có khả năng đáp ứng những nhu cầu.
- **Hệ thống quản lý chất lượng** (Quality Management System): Là hệ thống để định hướng và kiểm soát một tổ chức về mặt chất lượng.
- **Chính sách chất lượng** (Quality Policy): Ý đồ và định hướng chung của một tổ chức có liên quan đến chất lượng được lãnh đạo cao nhất công bố chính thức. [TCVN ISO 9000:2007, định nghĩa 3.2.4].
- **Mục tiêu chất lượng** (Quality objective): là điều định tìm kiếm hay nhằm tới có liên quan đến chất lượng.

- **Đảm bảo chất lượng** (Quality Assurance): Là một phần của quản lý chất lượng, tập trung vào việc cung cấp lòng tin rằng các yêu cầu chất lượng sẽ được thực hiện.
- **Cải tiến liên tục** (Continual Improvement): Là hoạt động lặp lại để nâng cao khả năng thực hiện các yêu cầu chất lượng.
- **Kiểm tra chất lượng** (Quality Control): Là một phần của quản lý chất lượng, tập trung vào việc thực hiện các yêu cầu chất lượng.
- **Nội kiểm tra** (Internal Quality Control): Là các quy trình được chính nhân viên Khoa xét nghiệm thực hiện để giám sát liên tục và nhanh quy trình xét nghiệm. IQC thực hiện phân tích trên mẫu chứng đã được biết trước khoảng giá trị. IQC được thực hiện hàng ngày trong Khoa xét nghiệm. Nó giúp phát hiện lỗi trong khi thực hiện xét nghiệm thường quy.
- **Kiểm tra chất lượng bên ngoài** (External Quality Assessment): Là một hệ thống do một cơ quan độc lập bên ngoài triển khai để đánh giá chất lượng của các Khoa xét nghiệm trong cùng khu vực. Đơn vị này sẽ gửi các mẫu đồng nhất tới các Khoa xét nghiệm tham gia. Tại các Khoa xét nghiệm sẽ thực hiện phân tích như mẫu bệnh nhân. Sau đó đơn vị tổ chức ngoại kiểm sẽ tổng hợp kết quả để so sánh và đánh giá chất lượng của từng Khoa xét nghiệm. Qua các báo cáo đánh giá từ đơn vị tổ chức, Khoa xét nghiệm sẽ thực hiện cải thiện chất lượng xét nghiệm của mình.
- **Đánh giá bên ngoài** (External audit): Do bên thứ hai (như khách hàng, hoặc đại diện của khách hàng) hoặc các tổ chức đánh giá độc lập bên ngoài tiến hành, (như các tổ chức thực hiện việc chứng nhận/đăng ký sự phù hợp với các yêu cầu của TCVN hay ISO). [TCVN ISO 9000:2007, định nghĩa 3.9.1, chú thích 2]
- **Đánh giá nội bộ** (Internal audit): Do tổ chức tự tiến hành với mục đích xem xét của lãnh đạo và các mục đích nội bộ khác và có thể làm cơ sở cho việc tự công bố sự phù hợp của tổ chức. [TCVN ISO 9000:2007, định nghĩa 3.9.1, chú thích 1]
- **Độ chính xác của phép đo** (Accuracy of measurement): Là mức độ gần nhau giữa các kết quả đo và giá trị thực của đại lượng đo. [TCVN 6165:1996 (VIM: 1993), định nghĩa 3.5]

- **Độ đúng của phép đo** (Trueness of measurement): Mức độ thống nhất giữa giá trị trung bình thu được từ loạt các kết quả đo và giá trị thực. [ISO 3534-1:1993, định nghĩa 3.12]
- **Độ không đảm bảo đo** (Uncertainty of measurement): Là đặc tính gắn với kết quả của phép đo, đặc trưng cho sự phân tán của các giá trị có thể quy cho đại lượng đo một cách hợp lý. [TCVN 6165:1996 (VIM: 1993), định nghĩa 3.9]
- **Hành động khắc phục** (Corrective action): Hành động để loại bỏ nguyên nhân của sự không phù hợp đã được phát hiện hay tình trạng không mong muốn khác. [TCVN ISO 9000:2007, định nghĩa 3.6.5]
- **Hành động phòng ngừa** (Preventive action): Hành động để loại bỏ nguyên nhân của sự không phù hợp tiềm tàng hay các tình trạng không mong muốn tiềm tàng khác. [TCVN ISO 9000:2007, định nghĩa 3.6.4]
- **Hiệu chuẩn** (Calibration): Là tập hợp các thao tác trong điều kiện quy định để thiết lập mối quan hệ giữa các giá trị được chỉ bởi phương tiện đo, hệ thống đo với các giá trị tương ứng thể hiện từ chất chuẩn, từ đó có các biện pháp xử lý và hiệu chỉnh kịp thời phù hợp với mục tiêu xét nghiệm.
- **Quy trình trước xét nghiệm** (Pre-examination procedure): Là các bước bắt đầu từ yêu cầu của bác sĩ lâm sàng bao gồm xét nghiệm chỉ định, chuẩn bị cho bệnh nhân, lấy mẫu bệnh phẩm, vận chuyển mẫu đến Khoa xét nghiệm và kết thúc khi quy trình xét nghiệm bắt đầu thực hiện.
- **Quy trình xét nghiệm** (Examination Procedures): Các hoạt động hoặc các bước để thực hiện các xét nghiệm.
- **Quy trình sau xét nghiệm** (Post-examination Procedure): Là giai đoạn sau phân tích, bao gồm kiểm tra, đọc kết quả, thẩm quyền ký kết quả, báo cáo, trả kết quả và lưu giữ mẫu xét nghiệm.
- **Khoảng cảnh báo** (Alert interval): khoảng kết quả xét nghiệm của thử nghiệm cảnh báo (nguy hiểm) cho biết rủi ro tổn thương hoặc tử vong ngay lập tức cho bệnh nhân.
- **Lựa chọn và báo cáo kết quả tự động** (Automated selection and reporting of results): Quá trình theo đó kết quả xét nghiệm của bệnh nhân được gửi tới hệ thống thông tin của phòng thí nghiệm, được so sánh với tiêu chí chấp nhận xác định của phòng thí nghiệm

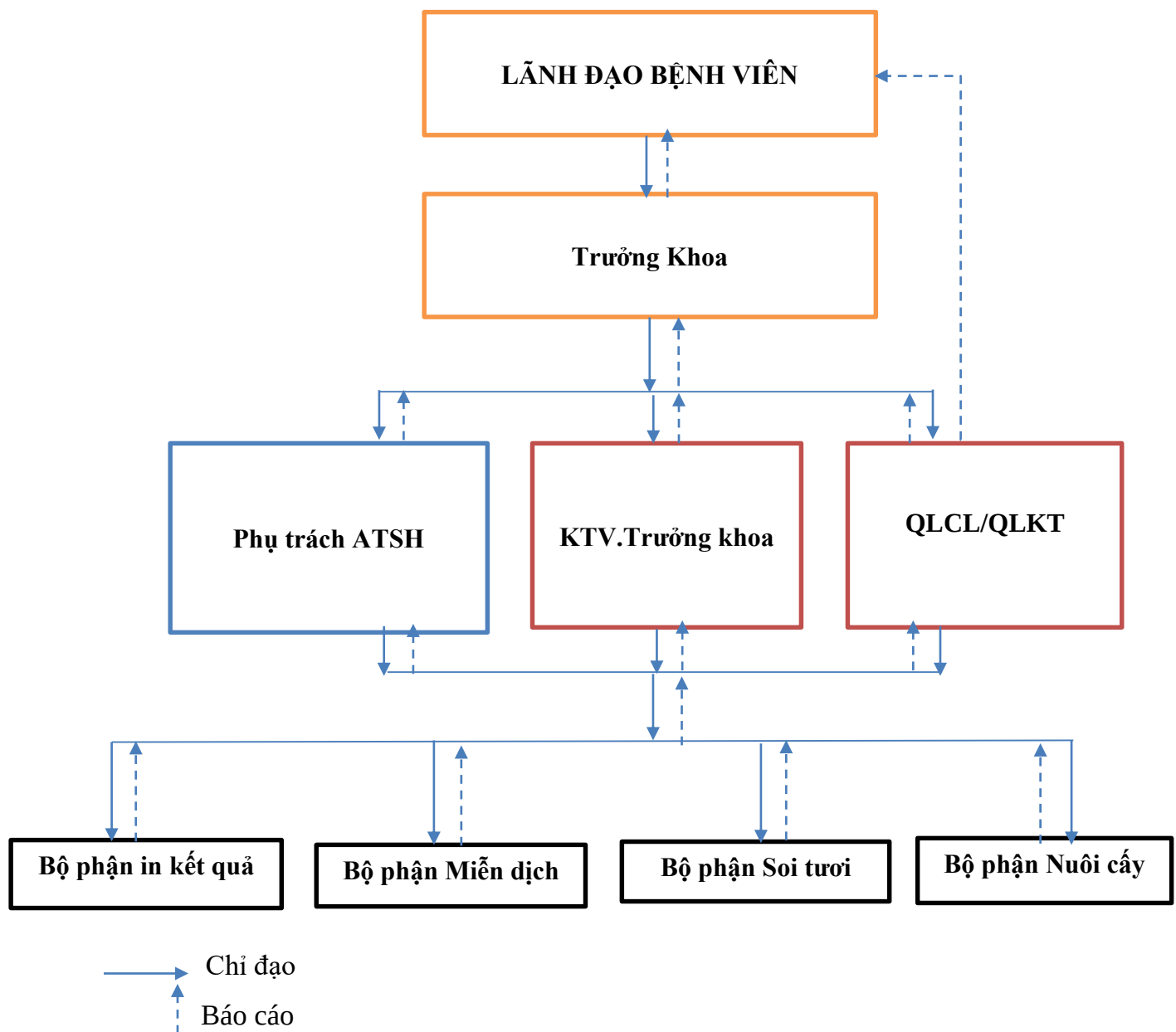
và các kết quả thuộc phạm I chuẩn mực xác định được tự động đưa vào dạng báo cáo của bệnh nhân mà không có bất kỳ can thiệp nào.

- **Khoảng chuẩn sinh học** (Biological reference interval): Khoảng xác định của phân bố các giá trị lấy từ giá trị tổng thể chuẩn sinh học.
- **Năng lực** (Competence): Khả năng được chứng tỏ để áp dụng kiến thức và kỹ năng
- **Quy trình/phương pháp dạng văn bản** (Documented procedure): Cách xác định để thực hiện một hoạt động hay quá trình được lập thành văn bản, áp dụng và duy trì.
- **So sánh liên phòng** (Interlaboratory comparison): Việc tổ chức, thực hiện và đánh giá các phép đo hoặc phép thử trên cùng mẫu thử hoặc trên mẫu thử tương tự nhau bởi hai hay nhiều phòng thí nghiệm theo những điều kiện xác định trước.
- **Sự không phù hợp** (Non conformity): Là sự không hoàn chỉnh của một vấn đề xảy ra đủ nghiêm trọng làm cho dịch vụ không đáp ứng yêu cầu mong muốn.
- **Tài liệu** (Documents): Có thể là mọi thông tin hoặc hướng dẫn bao gồm những công bố chính sách, các thủ tục, các hướng dẫn kỹ thuật, bảng hiệu chuẩn, khoảng tham chiếu sinh học và các tài liệu có nguồn gốc bên ngoài như các quy định, tiêu chuẩn hoặc các quy trình xét nghiệm bao gồm cả bản điện tử.
- **Kiểm tra xác nhận phương pháp** (Method verification): Quá trình cung cấp các bằng chứng khách quan rằng với điều kiện cụ thể của PTN (nguyên vật liệu, thiết bị, nhân sự, môi trường) phương pháp đó vẫn đáp ứng được các yêu cầu cụ thể. Thường áp dụng cho các phương pháp đã được thẩm định. [Technical Note 17 – Guidelines for the validation and verification of chemical test methods, 2009, NATA]
- **Mẫu** (Sample): Một hoặc nhiều phần lấy từ mẫu ban đầu. [ISO 15189:2012, định nghĩa 3.16]
- **Mẫu ban đầu** (Primary sample): Một phần của dịch cơ thể, đường thở, tóc hoặc mô lấy ra để xét nghiệm, nghiên cứu hoặc phân tích định lượng hoặc định tính, từ đó đưa ra kết luận chung cho toàn bộ cơ thể. [ISO 15189:2012, định nghĩa 3.16]
- **Năng lực** (Laboratory capability): Tiềm năng đã được chứng minh về ứng dụng kiến thức và kỹ năng. [TCVN ISO 9000:2007, định nghĩa 3.1.6]

- **Phòng xét nghiệm tham chiếu/bên ngoài** (Referral laboratory): Là PXN bên ngoài nơi mẫu được đưa đến để kiểm tra bổ sung hoặc kiểm tra xác nhận và để báo cáo. [TCVN 7782:2008, định nghĩa 3.15]
- **So sánh liên phòng** (Interlaboratory comparison): Tổ chức, thực hiện và đánh giá phép đo hoặc xét nghiệm trên những mẫu tương tự nhau do hai hoặc nhiều Khoa xét nghiệm thực hiện theo các điều kiện định sẵn. [ISO/IEC 17043:2010, định nghĩa 3.4]
- **Sự không phù hợp** (Nonconformity): Sự không đáp ứng một yêu cầu. [TCVN ISO 9000:2007, định nghĩa 3.6.2]
- **Thời gian trả lời kết quả xét nghiệm** (Turnaround time): Khoảng thời gian giữa hai thời điểm bắt đầu từ giai đoạn trước xét nghiệm, qua giai đoạn xét nghiệm đến khi trả kết quả cho bệnh nhân.

4. Sơ đồ tổ chức và trách nhiệm quản lý

4.1. Sơ đồ tổ chức khoa Vi sinh-Miễn dịch



4.2. Trách nhiệm và quyền hạn của các cá nhân trong hệ thống quản lý chất lượng**4.2.1. Lãnh đạo Bệnh viện**

- Định hướng phát triển Khoa Vi sinh-Miễn dịch phù hợp với mục tiêu phát triển chung của bệnh viện.
- Xây dựng chính sách chất lượng nhằm đảm bảo chất lượng xét nghiệm cho khách hàng.
- Cam kết hỗ trợ nhân lực/kinh phí cho hoạt động triển khai hệ thống QLCL.
- Phê duyệt sổ tay chất lượng

4.2.2. Lãnh đạo Khoa

- Đảm bảo việc thực hiện chính sách chất lượng;
- Xây dựng kế hoạch hàng năm của Khoa nhằm đảm bảo các nguồn lực cần thiết cho Khoa;
- Giám sát các hoạt động của Khoa;
- Quản lý, phân công công việc cho cán bộ QLCL, QLKT.;
- Phê duyệt các quy trình và hướng dẫn của Khoa;
- Tư vấn về chuyên môn;
- Lựa chọn và giám sát nhà cung cấp và chất lượng PXN tham chiếu;
- Chủ trì giải quyết các khiếu nại, yêu cầu, đề xuất của nhân viên;
- Xử lý những thiếu sót, yếu kém của HTQLCL và giám sát các hoạt động khắc phục;
- Định hướng cải tiến chất lượng;
- Xác định các nhu cầu đào tạo và đánh giá công việc của nhân viên;
- Tạo điều kiện cho nhân viên tham gia các chương trình phát triển chuyên môn và đào tạo;
- Đảm bảo điều kiện an toàn cho nhân viên và khách hàng;
- Thiết lập các kế hoạch dự phòng nhằm đảm bảo không gián đoạn dịch vụ;
- Là người có thẩm quyền ký phiếu trả lời kết quả xét nghiệm;
- Chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo bệnh viện và khách hàng sử dụng dịch vụ xét nghiệm về kết quả xét nghiệm;
- Bảo đảm sự chính xác và tính nhất quán của các quy trình xét nghiệm bằng việc xem xét, đánh giá và triển khai thực hiện các quy trình mới;
- Lập kế hoạch và điều hành hoạt động nghiên cứu và phát triển;

- Báo cáo trực tiếp kết quả công việc và các vấn đề phát sinh của Khoa cho lãnh đạo bệnh viện.

4.2.3. Quản lý chất lượng của Khoa

- Giám sát và duy trì hoạt động của HTQLCL;
- Quản lý và cập nhật nội dung tài liệu, hồ sơ liên quan đến hệ thống quản lý chất lượng;
- Đảm bảo tính bảo mật của thông tin, dữ liệu;
- Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện đánh giá nội bộ, xem xét của lãnh đạo, tham gia các chương trình ngoại kiểm;
- Kiểm soát sự không phù hợp và tổ chức thực hiện các hoạt động khắc phục, phòng ngừa và cải tiến chất lượng;
- Báo cáo trực tiếp kết quả công việc và các vấn đề phát sinh cho lãnh đạo Khoa.

4.2.4. Quản lý kỹ thuật của Khoa

- Chịu trách nhiệm chính về các vấn đề liên quan đến kỹ thuật xét nghiệm;
- Tổ chức đào tạo kỹ thuật và kiểm tra tay nghề nhân viên;
- Đảm nhiệm hoặc phân công người quản lý thiết bị, vật tư;
- Giám sát việc kiểm soát điều kiện tiện nghi và môi trường;
- Lập kế hoạch và giám sát việc kiểm tra, bảo dưỡng, thử nghiệm, hiệu chuẩn thiết bị;
- Giám sát thực hiện phê duyệt phương pháp và đảm bảo chất lượng xét nghiệm;
- Xem xét kết quả xét nghiệm trước khi trình Trưởng Khoa.
- Báo cáo trực tiếp kết quả công việc và các vấn đề phát sinh cho lãnh đạo Khoa.

4.2.5. Nhân viên PXN

- Tuân thủ các chính sách, quy định, quy trình và hướng dẫn của HTQLCL;
- Tham gia thực hiện các hoạt động của HTQLCL;
- Hoàn thành các nhiệm vụ theo phân công của lãnh đạo PTN.
- Đề xuất cải tiến HTQLCL.

5. Các yêu cầu cụ thể

5.1. Tổ chức quản lý

5.1.1. Tổ chức và trách nhiệm quản lý

- Sơ đồ tổ chức và trách nhiệm quản lý của Khoa được mô tả trong mục 3 của Sổ tay chất lượng.
- Khoa tuân thủ các quy định về y đức trong quyết định số 2088/BYT-QĐ ngày 6 tháng 11 năm 1996 của Bộ trưởng Bộ Y tế và thông tư/quyết định (nêu tên văn bản quy định riêng cho lĩnh vực xét nghiệm cụ thể của Khoa).
- Lãnh đạo khoa và nhân viên trong khoa đều phải ký cam kết đảm bảo không chịu bất kỳ áp lực về thương mại, tài chính và các áp lực khác ảnh hưởng tới chất lượng công việc đang thực hiện.
- Chính sách và mục tiêu chất lượng được mô tả trong mục 2.1; 2.2. của STCL. Hằng năm, Khoa xây dựng kế hoạch chất lượng để đảm bảo hoàn thành các mục tiêu chất lượng đề ra.
- Phổ biến thông tin (chính sách, quy định, quy trình v.v.) cho lãnh đạo và nhân viên bằng nhiều hình thức: họp, email, Zalo v.v.
- Nội dung chi tiết các hoạt động liên quan đến tổ chức và quản lý được mô tả trong quy trình: “Tổ chức và trách nhiệm quản lý” (mã số: XN-QTQL 5.1.1).
- “Hồ sơ tổ chức và trách nhiệm quản lý” (mã số: HS-5.1) được quản lý và lưu giữ theo quy trình “Quản lý hồ sơ” (mã số: XN-QTQL 5.2.3).

5.1.2. Xem xét của lãnh đạo

- Định kỳ hằng năm, Lãnh đạo Bệnh viện và Lãnh đạo Khoa sẽ xem xét HTQLCL nhằm đảm bảo hệ thống luôn phù hợp với các yêu cầu của quốc gia, quốc tế và hỗ trợ hiệu quả cho công tác chăm sóc bệnh nhân.
- Lãnh đạo Bệnh viện và Lãnh đạo Khoa phải phân tích các thông tin đầu vào để xác định nguyên nhân của sự không phù hợp, xu hướng và tình huống có vấn đề và các cơ hội cải tiến.
- Kết quả của xem xét lãnh đạo là các hoạt động nhằm cải tiến hiệu quả của HTQLCL, cải tiến dịch vụ và các nhu cầu về nguồn lực.

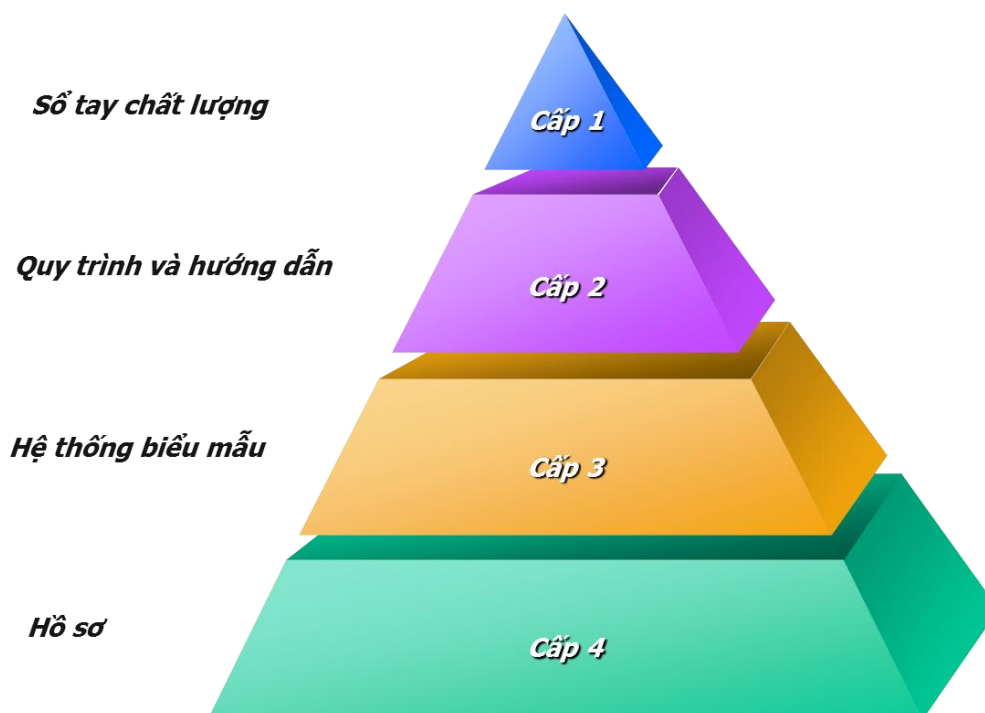
- Nội dung chi tiết liên quan đến các hoạt động xem xét của lãnh đạo được quy định trong quy trình “Xem xét của lãnh đạo” (mã số: XN-QTQL 5.1.3).
- Các hồ sơ liên quan đến hoạt động xem xét của lãnh đạo được quản lý và lưu giữ theo quy trình “Quản lý hồ sơ” (mã số: XN-QTQL 5.2.3).

5.2. Tài liệu và hồ sơ

5.2.1 Tài liệu hệ thống quản lý

Để triển khai và duy trì HTQLCL, Khoa xây dựng hệ thống tài liệu gồm 4 cấp:

- Cấp 1: Sổ tay chất lượng (STCL) của Khoa mô tả HTQLCL của Khoa và cấu trúc của hệ thống tài liệu sử dụng trong HTQLCL. STCL quy định các hoạt động cần thiết để đảm bảo chất lượng dịch vụ của Khoa.
- Cấp 2: Quy trình và hướng dẫn
 - + QTQL: mô tả các bước thực hiện các hoạt động quản lý của HTQLCL.
 - + QTXN: mô tả trình tự các bước thực hiện một xét nghiệm.
 - + QTKT: mô tả các bước thực hiện một kỹ thuật cụ thể.
 - + HDCV: mô tả chi tiết các bước thực hiện một công việc cụ thể.
 - + HDTB: nêu chi tiết các bước vận hành/bảo dưỡng/vệ sinh một thiết bị cụ thể.
 - + HDAT: nêu chi tiết các bước thực hiện nhằm đảm bảo an toàn cho con người và môi trường của khu vực xét nghiệm.
- Cấp 3: hệ thống biểu mẫu
- Cấp 4: hồ sơ



Các tài liệu này được kiểm soát theo quy trình “Kiểm soát tài liệu” (mã số: XN-QTQL 5.2.1)

5.2.2. Kiểm soát tài liệu

- Khoa kiểm soát tất cả các tài liệu liên quan đến hệ thống quản lý (gồm tài liệu nội bộ và tài liệu từ bên ngoài) mà có thể thay đổi theo phiên bản hoặc thời gian. Tài liệu thuộc diện kiểm soát có thể ở dạng văn bản hoặc điện tử và đều có dấu hiệu nhận biết.
- Khoa không kiểm soát các bản sao dùng làm tài liệu tham khảo hoặc tài liệu đào tạo.
- Nội dung kiểm soát liên quan đến các hoạt động chính sau:
 - + Ban hành tài liệu: các tài liệu nội bộ khi ban hành phải được cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt. Trên tài liệu có thông tin về ngày ban hành, lần ban hành.
 - + Phân phối tài liệu: tài liệu được phân phối, phổ biến và sẵn có cho người có liên quan sử dụng. Tài liệu phổ biến cho người sử dụng luôn là tài liệu phiên bản mới nhất.
 - + Lưu giữ tài liệu: các bản gốc được lưu giữ ở nơi an toàn và chỉ người có thẩm quyền mới được tiếp cận và sao chép tài liệu. Những tài liệu cũ, hết hiệu lực được thu hồi, lưu giữ riêng và có dấu hiệu nhận biết rõ ràng.
 - + Sửa đổi tài liệu: cho phép sửa đổi nhưng mọi nội dung sửa đổi đều được xem xét và phê duyệt trước khi áp dụng.

+ Định kỳ xem xét tài liệu nhằm đảm bảo nội dung tài liệu luôn phù hợp với chính sách, quy định hiện hành và thực tế của đơn vị.

- Nội dung chi tiết của việc kiểm soát tài liệu được quy định trong quy trình “Kiểm soát tài liệu” (mã số: XN-QTQL 5.2.1).

Hồ sơ liên quan đến việc kiểm soát tài liệu được quản lý và lưu giữ theo quy trình “Quản lý hồ sơ” (mã số: XN-QTQL 5.2.3).

5.2.3. Quản lý hồ sơ

- Khoa quản lý các loại hồ sơ phát sinh trong quá trình hoạt động gồm hồ sơ quản lý và hồ sơ kỹ thuật. Hồ sơ có thể ở dạng văn bản hoặc điện tử.

- Khoa quy định thời gian lưu với từng loại hồ sơ và đảm bảo các điều kiện bảo quản phù hợp để tránh hồ sơ bị hư hại, mất hoặc truy cập trái phép.

- Nội dung chi tiết liên quan đến quản lý hồ sơ được quy định trong quy trình “Quản lý hồ sơ” (mã số: XN-QTQL 5.2.3).

5.3. Quản lý nhân sự

- Khoa được Bệnh viện đảm bảo đủ nguồn nhân lực để thực hiện các chức năng chuyên môn và quản lý hệ thống chất lượng.

- Khoa đảm bảo các nhân viên được tuyển chọn có trình độ, kinh nghiệm, năng lực và phẩm chất phù hợp với vai trò và nhiệm vụ được giao.

- Lãnh đạo Khoa là những người có đủ trình độ chuyên môn và kinh nghiệm phù hợp với các quy trình xét nghiệm được thực hiện tại Khoa.

- Lãnh đạo và nhân viên của Khoa đều có bản mô tả công việc trong đó chỉ rõ trách nhiệm, quyền hạn và nghĩa vụ của mỗi cá nhân.

- Nhân viên mới được tuyển dụng sẽ được hướng dẫn để làm quen và hiểu về môi trường làm việc tại Khoa.

- Hàng năm, Lãnh đạo Khoa xây dựng kế hoạch đào tạo cho nhân viên căn cứ vào nhu cầu đào tạo của các cá nhân và nguồn lực của Viện, Khoa. Nhân viên trong quá trình đào tạo đều có người giám sát.

- Sau khi đào tạo và định kỳ hằng năm, nhân viên Khoa đều được đánh giá năng lực về nội dung đào tạo hoặc nhiệm vụ, kỹ thuật được phân công.

- Cuối năm, lãnh đạo và nhân viên Khoa tiến hành xem xét, đánh giá lại toàn bộ quá trình làm việc trong năm nhằm duy trì và cải tiến chất lượng dịch vụ.

- Hằng năm, Khoa cũng tạo điều kiện để nhân viên tham gia các chương trình đào tạo liên tục và phát triển chuyên môn.
- Nội dung chi tiết liên quan đến nhân sự được quy định trong quy trình “Quản lý nhân sự” (mã số: XN-QTQL 5.3.1).
- Các hồ sơ liên quan đến hoạt động quản lý nhân sự được quản lý và lưu giữ theo quy trình “Quản lý hồ sơ” (mã số: XN-QTQL 5.2.3).

5.4. Dịch vụ và quản lý khách hàng

5.4.1. Dịch vụ tư vấn

- Khoa cung cấp dịch vụ tư vấn liên quan đến việc quy trình trước xét nghiệm (bao gồm lựa chọn xét nghiệm, loại mẫu thích hợp, v.v) và quy trình sau xét nghiệm (diễn giải kết quả xét nghiệm) trực tiếp hoặc gián tiếp (email, điện thoại, zalo.v.v.).
- Nội dung chi tiết liên quan đến dịch vụ tư vấn được quy định trong “Quy trình dịch vụ tư vấn” (mã số: XN-QTQL 5.4.01)

Hồ sơ liên quan đến dịch vụ tư vấn được quản lý và lưu giữ theo quy trình “Quản lý hồ sơ” (mã số: XN-QTQL 5.2.3).

5.4.2. Giải quyết khiếu nại

- Mọi khiếu nại, phàn nàn của khách hàng liên quan đến hoạt động của Khoa đều phải được giải quyết kịp thời nhằm thỏa mãn các yêu cầu chính đáng của khách hàng và xác định các sự không phù hợp để khắc phục hoặc cơ hội cải tiến.
- Nội dung chi tiết liên quan đến giải quyết khiếu nại của khách hàng được quy định trong quy trình “Giải quyết khiếu nại” (mã số: XN-QTQL 5.4.2).
- Các hồ sơ liên quan đến việc tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, phàn nàn của khách hàng được quản lý và lưu giữ theo quy trình “Quản lý hồ sơ” (mã số: XN-QTQL 5.2.3).

5.5. Quản lý trang thiết bị:

- Khoa được trang bị đầy đủ các thiết bị cần thiết để thực hiện các dịch vụ.
- Khi nhận thiết bị mới, Khoa tiến hành kiểm tra nghiệm thu để đảm bảo thiết bị đạt được các tính năng cần thiết và phù hợp với yêu cầu của xét nghiệm.
- Các thiết bị đều có mã duy nhất và người quản lý chịu trách nhiệm đảm bảo điều kiện hoạt động tối ưu cho thiết bị.
- Hướng dẫn vận hành/bảo dưỡng thiết bị phải sẵn có ở khu vực xét nghiệm.

- Chỉ nhân viên đã qua đào tạo mới được vận hành thiết bị.
- Định kỳ các thiết bị được bảo dưỡng, kiểm tra, thử nghiệm và hiệu chuẩn theo khuyến cáo của nhà sản xuất và yêu cầu của cơ quan công nhận.
- Khoa không sử dụng các thiết bị hỏng, không đạt yêu cầu để thực hiện các dịch vụ xét nghiệm. Khi có sự cố về thiết bị, cần tuân thủ quy trình “Kiểm soát sự không phù hợp” (mã số: XN-QTQL 5.10.1).
- Các thiết bị trước khi sửa chữa và thanh lý đều được khử nhiễm nhằm đảm bảo an toàn.
- Tất cả thiết bị đều có hồ sơ đi kèm được lưu giữ trong suốt vòng đời của thiết bị.
- Nội dung chi tiết liên quan đến thiết bị được quy định trong quy trình “Quản lý thiết bị” (mã số: XN-QTQL 5.5.1).
- Các hồ sơ liên quan đến thiết bị được quản lý và lưu giữ theo quy trình “Quản lý hồ sơ” (mã số: XN-QTQL 5.2.3).

5.6. Đánh giá nội bộ

- Khoa cần thực hiện các hoạt động đánh giá nhằm đảm bảo sự phù hợp của hệ thống quản lý chất lượng và liên tục cải tiến.
- Định kỳ hằng năm, Khoa tiến hành xem xét các xét nghiệm để đảm bảo tính phù hợp về mặt lâm sàng và xem xét các yêu cầu về mẫu để đảm bảo lượng mẫu lấy vừa đủ và đúng quy cách.
- Định kỳ hằng năm, Khoa tổ chức khảo sát đánh giá của khách hàng về chất lượng dịch vụ và thực hiện các hành động khắc phục, cải tiến nếu phù hợp.
- Lãnh đạo và nhân viên của Khoa đều có quyền đề xuất các cải tiến ở bất kỳ lĩnh vực nào trong HTQLCL của Khoa.
- Định kỳ hằng năm, Khoa tổ chức đánh giá nội bộ toàn bộ các khía cạnh của HTQLCL nhằm xác định sự phù hợp của hệ thống với các yêu cầu trong tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế; phát hiện các sự không phù hợp và cơ hội để cải tiến.
- Định kỳ hằng năm, Khoa tiến hành đánh giá các nguy cơ có thể ảnh hưởng tới kết quả xét nghiệm, an toàn của nhân viên, bệnh nhân và môi trường.
- Khoa thiết lập và theo dõi các chỉ số chất lượng để giám sát và đánh giá việc thực hiện các bước quan trọng của quá trình xét nghiệm.

- Khoa phải đảm bảo thực hiện các hành động phù hợp đối với các sự không phù hợp hoặc sự không phù hợp tiềm ẩn được phát hiện trong quá trình đánh giá bên ngoài.
- Nội dung chi tiết liên quan đến các hoạt động đánh giá được quy định trong quy trình “Đánh giá hệ thống quản lý chất lượng” (mã số: QTQL 5.6.1).
- Các hồ sơ liên quan đến hoạt động đánh giá được quản lý và lưu giữ theo quy trình “Quản lý hồ sơ” (mã số: XN-QTQL 5.2.3).

5.7 Quản lý mua sắm hóa chất, vật tư, sinh phẩm

5.7.1. Mua sắm và dịch vụ bên ngoài

- Khoa sẽ đề xuất nhà cung cấp dịch vụ/vật tư với cho Phòng Vật tư – Thiết bị y tế và lãnh đạo Bệnh viện dựa trên đề xuất yêu cầu chất lượng hàng hóa – dịch vụ.
- Hằng năm, Khoa sẽ tiến hành đánh giá nhà cung cấp làm cơ sở cho Phòng Vật tư – Thiết bị y tế quyết định nhà cung cấp cho các đợt hàng tiếp theo.
- Khi có nhu cầu mua sắm dịch vụ/vật tư bên ngoài, Khoa sẽ tuân thủ các quy trình của Bệnh viện bao gồm:

- + Quy trình mua sắm và quản lý trang thiết bị:

- + Quy trình sửa chữa nhỏ:

- Nội dung chi tiết liên quan đến sử dụng dịch vụ/vật tư được quy định trong “Quy trình mua sắm và dịch vụ bên ngoài” (mã số: QTQL 5.7.1).
- Hồ sơ liên quan đến việc sử dụng dịch vụ/vật tư được quản lý và lưu giữ theo quy trình “Quản lý hồ sơ” (mã số: XN-QTQL 5.2.3).

5.7.2. Hóa chất, vật tư, sinh phẩm

- Khoa tiếp nhận hóa chất, sinh phẩm và vật tư tiêu hao (gọi chung là vật tư) từ kho Vật tư của Bệnh viện.
- Sau khi tiếp nhận, Khoa bảo quản vật tư ở điều kiện theo đúng khuyến cáo của nhà sản xuất.
- Vật tư đều được kiểm tra chất lượng trước khi sử dụng.
- Hướng dẫn sử dụng vật tư (nếu có) luôn sẵn có ở khu vực xét nghiệm.
- Khi có sự cố về vật tư, cần tuân thủ quy trình “Kiểm soát sự không phù hợp” (mã số: XN-QTQL 5.10.1).
- Khoa lưu giữ hồ sơ cho các vật tư được sử dụng trong quá trình xét nghiệm.

- Nội dung chi tiết liên quan đến vật tư được quy định trong quy trình “Quản lý vật tư” (mã số: XN-QTQL 5.7.2).

Các hồ sơ liên quan đến vật tư được quản lý và lưu giữ theo quy trình “Quản lý hồ sơ” (mã số: XN-QTQL 5.2.3).

5.8. Quản lý quá trình xét nghiệm

5.8.1. Quá trình trước xét nghiệm

- Khoa có cuốn “Sổ tay lấy mẫu ban đầu”/ “Sổ tay dịch vụ khách hàng” trong đó cung cấp các thông tin cần thiết cho khách hàng.

- Các đơn vị/khoa gửi mẫu đến Khoa Vi sinh-Miễn dịch có thể sử dụng mẫu Phiếu yêu cầu xét nghiệm của đơn vị hoặc của Khoa xây dựng nhưng vẫn phải đảm bảo đầy đủ các thông tin cần thiết.

- Các quy trình, hướng dẫn liên quan đến quá trình lấy mẫu (chuẩn bị bệnh nhân, lấy mẫu, đóng gói, bảo quản và vận chuyển mẫu) đều sẵn có cho khách hàng và các đơn vị gửi mẫu.

- Khoa xây dựng tiêu chuẩn chấp thuận/từ chối đối với từng loại mẫu cụ thể để quyết định việc tiếp nhận mẫu.

- Khoa cũng có chính sách chấp nhận mẫu không đạt yêu cầu nếu là mẫu quan trọng, không thể thay thế nhưng phải chú thích rõ ràng trong phiếu trả lời kết quả xét nghiệm.

- Khoa có sổ nhận mẫu và quy định đánh mã mẫu sau khi tiếp nhận.

- Khoa cũng có quy định xử lý với trường hợp mẫu khẩn.

- Mẫu trước xét nghiệm được bảo quản và xử lý phù hợp để đảm bảo chất lượng xét nghiệm và an toàn, an ninh sinh học.

- Nội dung chi tiết liên quan đến quy trình trước xét nghiệm được quy định trong “Quy trình trước xét nghiệm” (mã số: XN-QTQL 5.8.1).

- Các hồ sơ liên quan đến quy trình trước xét nghiệm được quản lý và lưu giữ theo quy trình “Quản lý hồ sơ” (mã số: XN-QTQL 5.2.3).

5.8.2. Quá trình xét nghiệm

- Khoa ưu tiên lựa chọn và sử dụng các phương pháp, kỹ thuật đã được các tổ chức uy tín như Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Trung tâm phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh

(CDC), Viện Truyền nhiễm quốc gia Nhật Bản (NIID), Bộ Y tế Việt Nam v.v công nhận hoặc sách/tạp chí khoa học uy tín công bố.

- Khoa chỉ sử dụng các phương pháp đã được phê duyệt và xác nhận là phù hợp với mục đích sử dụng khi xét nghiệm.
- Khoa chỉ xác định độ không đảm bảo đo cho các xét nghiệm có kết quả là giá trị định lượng.
- Khoa có quy trình xét nghiệm cho từng loại xét nghiệm/tác nhân cụ thể và luôn sẵn có cho nhân viên tham khảo ở khu vực xét nghiệm và trên hệ thống phần mềm lưu trữ của bệnh viện.
- Nội dung chi tiết liên quan đến quy trình xét nghiệm được quy định trong các quy trình liên quan.
- Các hồ sơ liên quan đến quy trình xét nghiệm được quản lý và lưu giữ theo quy trình “Quản lý hồ sơ” (mã số: XN-QTQL 5.2.3).

5.8.3. Đảm bảo chất lượng kết quả xét nghiệm

- Khoa có hệ thống đảm bảo chất lượng xét nghiệm bao gồm:
 - + Nội kiểm tra: sử dụng mẫu kiểm soát chất lượng, phân tích dữ liệu kiểm soát chất lượng.
 - + Tham gia vào chương trình ngoại kiểm
 - + Kiểm tra tay nghề nhân viên;
- Nội dung chi tiết liên quan đến đảm bảo chất lượng xét nghiệm được quy định trong “Quy trình đảm bảo chất lượng kết quả xét nghiệm” (mã số: XN-QTQL 5.8.3)
- Khi phát hiện sự không phù hợp, Khoa sẽ thực hiện theo dõi theo quy trình “Kiểm soát sự không phù hợp” (mã số: QTQL 5.10.1) và khắc phục theo quy trình “Hành động khắc phục” (mã số: QTQL 5.10.2).
- Khoa tiến hành đánh giá độ tương đồng giữa các phương pháp, thiết bị khác nhau để góp phần kiểm soát các yếu tố ảnh hưởng tới độ tin cậy của kết quả xét nghiệm.
- Nội dung chi tiết liên quan đến hoạt động đảm bảo chất lượng xét nghiệm được quy định trong các quy trình liên quan.
- Các hồ sơ liên quan đến đảm bảo chất lượng xét nghiệm được quản lý và lưu giữ theo quy trình “Quản lý hồ sơ” (mã số: XN-QTQL 5.2.3).

5.8.4. Quá trình sau xét nghiệm

- Tất cả kết quả xét nghiệm đều phải do nhân viên có thẩm quyền (đủ năng lực) để xem xét.
- Việc xem xét dựa trên dữ liệu kiểm soát chất lượng, thông tin lâm sàng và các kết quả xét nghiệm trước đó.
- Khoa có hệ thống bảo quản và lưu giữ mẫu bệnh phẩm sau xét nghiệm.
- Khi hủy mẫu, Khoa tuân thủ các quy định về an toàn của Bệnh viện.
- Nội dung chi tiết liên quan đến đảm bảo chất lượng xét nghiệm được quy định trong:

Quy trình rà soát kết quả	XN-QTQL 5.8.8
Quy trình lưu và tiêu hủy bệnh phẩm	XN-QTQL 5.8.9
Quy trình trả kết quả xét nghiệm	XN-QTQL 5.8.10
Quy trình công bố kết quả	XN-QTQL 5.8.11

- Các hồ sơ liên quan đến quy trình sau xét nghiệm được quản lý và lưu giữ theo quy trình “Quản lý hồ sơ” (mã số: XN-QTQL 5.2.3).

5.9. Quản lý thông tin

- Khoa sử dụng hệ thống thông tin ở cả dạng văn bản (sổ, biểu mẫu v.v) và điện tử (file word, PDF, bảng tính excel v.v).
- Khoa quy định rõ thẩm quyền tiếp cận hệ thống thông tin nhằm đảm bảo tính bảo mật của thông tin.
- Khoa thiết lập phân quyền truy cập, sử dụng mật khẩu ở các máy tính sử dụng để nhập liệu và lập phiếu báo cáo xét nghiệm.
- Định kỳ phòng CNTT phối hợp với khoa Vi sinh-Miễn dịch tiến hành sao lưu để bảo vệ dữ liệu.
- Khoa có kế hoạch ứng phó với các tình huống bất ngờ để không làm ảnh hưởng tới khả năng cung cấp dịch vụ của Khoa.
- Nội dung chi tiết liên quan đến quản lý thông tin phòng thí nghiệm được quy định trong quy trình “Quản lý thông tin” (mã số: XN-QTQL 5.9.1).
- Các hồ sơ liên quan đến quy trình quản lý thông tin được quản lý và lưu giữ theo quy trình “Quản lý hồ sơ” (mã số: XN-QTQL 5.2.3).

5.10. Xác định sự không phù hợp, hành động khắc phục và hành động phòng ngừa.

5.10.1. Xác định và kiểm soát sự không phù hợp

- Bất kỳ khía cạnh nào trong hoạt động xét nghiệm không phù hợp với các quy định, quy trình đã được đề ra hoặc không đúng theo các yêu cầu đã được thỏa thuận đều được gọi là sự không phù hợp.
- Khoa phải kiểm soát sự không phù hợp bằng cách xác định trách nhiệm của các cá nhân liên quan, báo cáo, phân loại và xử lý sự không phù hợp.
- Nội dung chi tiết liên quan đến kiểm soát sự không phù hợp được quy định trong quy trình “Kiểm soát sự không phù hợp” (mã số: XN-QTQL 5.10.1).
- Các hồ sơ liên quan đến việc xác định và kiểm soát sự không phù hợp được quản lý và lưu giữ theo quy trình “Quản lý hồ sơ” (mã số: XN-QTQL 5.2.3).

5.10.2. Hành động khắc phục

- Khoa phải tiến hành các hành động khắc phục thích hợp để loại trừ sự không phù hợp.
- Khoa phải điều tra nguyên nhân gốc rễ của sự không phù hợp; thực hiện các biện pháp khắc phục, phòng ngừa tái diễn và đánh giá hiệu quả của hành động khắc phục.
- Nội dung chi tiết liên quan đến việc thực hiện hành động khắc phục được quy định trong quy trình “Hành động khắc phục” (mã số: XN-QTQL 5.10.2).
- Các hồ sơ liên quan đến hành động khắc phục được quản lý và lưu giữ theo quy trình “Quản lý hồ sơ” (mã số: XN-QTQL 5.2.3).

5.10.3. Hành động phòng ngừa

- Định kỳ hằng năm Khoa chủ động xác định các nguồn gốc tiềm tàng, nguy cơ có thể dẫn đến sự không phù hợp trong hệ thống quản lý chất lượng.
 - Khoa phải điều tra nguyên nhân gốc rễ của sự không phù hợp tiềm ẩn; thực hiện các biện pháp phòng ngừa và đánh giá hiệu quả của hành động phòng ngừa.
 - Nội dung chi tiết liên quan đến việc thực hiện hành động phòng ngừa được quy định trong quy trình “Hành động phòng ngừa” (mã số: XN-QTQL 5.10.3).
- Các hồ sơ liên quan đến hành động phòng ngừa được quản lý và lưu giữ theo quy trình “Quản lý hồ sơ” (mã số: XN-QTQL 5.2.3).

5.11. Cải tiến liên tục

- Hằng năm, Khoa chủ động xem xét các hoạt động để xác định các cơ hội cải tiến trong toàn bộ quá trình xét nghiệm bao gồm giai đoạn trước xét nghiệm, giai đoạn xét nghiệm và giai đoạn sau xét nghiệm.

- Khoa phải thực hiện các hành động cải tiến chất lượng hướng vào các lĩnh vực được ưu tiên dựa trên đánh giá nguy cơ và đánh giá hiệu quả của hành động cải tiến.

- Nội dung chi tiết liên quan đến việc thực hiện hành động cải tiến được quy định trong quy trình “Hành động phòng ngừa” (mã số: XN-QTQL 5.10.3).

Các hồ sơ liên quan đến hành động cải tiến được quản lý và lưu giữ theo quy trình “Quản lý hồ sơ” (mã số: XN-QTQL 5.2.3).

5.12. Cơ sở vật chất và an toàn

- Không gian làm việc của Khoa được bố trí phù hợp với công việc nhằm đảm bảo chất lượng, an toàn và hiệu quả của dịch vụ cung cấp cho người sử dụng, đảm bảo sức khỏe và an toàn cho nhân viên và khách hàng.

- Khoa có các biện pháp phù hợp để kiểm soát tiếp cận các khu vực có ảnh hưởng tới chất lượng xét nghiệm và sự toàn vẹn của thông tin, mẫu bệnh phẩm và các nguồn lực khác.

- Khu vực xét nghiệm được đảm bảo các điều kiện môi trường phù hợp: điện, nước, ánh sáng, thông gió v.v.

- Khu vực xét nghiệm được trang bị các thiết bị an toàn và trang bị bảo hộ cá nhân. Định kỳ Bệnh viện, Khoa sẽ kiểm tra các tiện nghi an toàn này.

- Khoa bố trí không gian và điều kiện thích hợp để bảo quản mẫu, tài liệu, hồ sơ, thiết bị, hóa chất, sinh phẩm, vật tư tiêu hao nhằm đảm bảo tính toàn vẹn và ngăn ngừa lây nhiễm chéo.

- Khoa không lấy mẫu trực tiếp nên không có khu vực lấy mẫu riêng biệt, tuy nhiên Khoa có bố trí phòng lấy các mẫu bệnh phẩm STD.

- Khu vực làm việc của Khoa luôn đảm bảo vệ sinh. Hàng ngày, nhân viên PXN đều theo dõi điều kiện nhiệt độ các thiết bị bị hỗ trợ trong phòng xét nghiệm, độ ẩm của khu vực xét nghiệm.

- Nội dung chi tiết liên quan đến các điều kiện tiện nghi và môi trường được quy định trong quy trình “Điều kiện tiện nghi và môi trường” (mã số: XN-QTQL 5.12.1).

Các hồ sơ liên quan đến điều kiện tiện nghi và môi trường được quản lý và lưu giữ theo quy trình “Quản lý hồ sơ” (mã số: XN-QTQL 5.2.3).

6. Tài liệu tham khảo

- Thông tư 01/2013/TT-BYT ngày 11 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về Hướng dẫn bảo đảm chất lượng xét nghiệm đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
- Quyết định Số: 5530/QĐ-BYT về “Hướng dẫn xây dựng quy trình thực hành chuẩn trong quản lý chất lượng xét nghiệm” tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
- Quyết định số 2429/QĐ-BYT ngày 12 tháng 6 năm 2017 về Ban hành Tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học.
- TCVN ISO 15189:2014 (ISO 15189:2012) Phòng thí nghiệm Y tế – Yêu cầu về chất lượng và năng lực, Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng, 2014.
- ISO 15189:2012, Medical laboratories - Requirements for quality and competence, 2012.